SPECIAL EDUCATION · CRISIS BEHAVIOR SUPPORT GUIDE

장애학생 위기행동 이해·예방·대응 종합 가이드

개념 설명서 · 예방 및 단계별 대응 지침서 · 사례 기반 PBS 종합보고서 · 초심자 현장 지원 해설서 합본

위기행동은 우발적으로 터지는 것처럼 보여도 실제로는 일정한 단계를 거쳐 고조됩니다. 이 가이드는 **① 위기행동의 이해 → ② 평가와 예방 중재 → ③ 교내 체계 구축 → ④ 위기 발생 시 대응 → ⑤ 유형별 사례 → ⑥ 사후 행정·법률·회복 지원** 순서로, 현장에서 필요한 내용을 한 흐름으로 정리했습니다. 중재의 대원칙은 하나입니다. **"안전을 신속히 확보하고, 조속히 정상 일과로 복귀시킨다."** 위기행동 중재는 처벌이나 배제의 수단이 아닙니다.

1	2	3	4	5	6
이해	평가·예방	교내 체계	위기 대응	유형별 사례	사후 지원

목차

1. 위기행동의 이해
2. 평가와 예방 중재 (PBS)
3. 교내 위기관리 체계 구축
4. 위기 발생 시 단계별 대응
5. 유형별·상황별 사례와 맞춤 전략
6. 사후 행정·법률·회복 지원
7. 핵심 5대 수칙과 실행 제언

※ 교권보호위원회·교원치유지원센터·정신응급개입 등 지역 기관 정보는 원자료(전라북도 기준)를 따랐습니다. 금액·기한·연락처는 시점과 지역에 따라 다를 수 있으니 적용 전 확인하세요.

1. 위기행동의 이해

1.1 일반 문제행동과 위기행동의 구별

위기행동은 장애학생 본인과 주변 사람(교사, 특수교육실무사, 또래)의 **신체적·심리적 안전을 심각하게 위협**하는 행동으로, 일상적 지도로는 통제하기 어렵고 즉각적인 물리적·의료적·행정적 개입이 필요합니다(Stevenson, 2018). 초보 교사는 소리 지르기나 과제 거부를 곧바로 위기상황으로 착각하곤 하므로, 위험 수준에 따라 개입 수위를 구별해야 합니다.

구분	일반 문제행동	위기행동
정의	수업을 방해하거나 사회적 규칙에 어긋나는 일상적 부적응 행동	자신이나 타인의 신체·생명·안전을 심각하게 위협하는 폭발적 행동
위험 수준	주의 산만, 과제 거부, 경미한 소음 등 신체적 위해가 없는 수준	자해, 타해, 폭행, 창문 파손 등 심각한 상해·물적 손해 발생
개입	차분한 교정, 점진적 긍정적 행동지원(PBS) 적용 가능	현장 즉시 응급 개입, 긴급 체계 가동 필수
중재 목표	대안적 의사소통 습득, 규칙 준수 지도	신체적 안전 확보, 자극 차단, 긴급 이송, 비상 상황의 조기 해소

문제행동의 강도에 따른 3수준 분류도 함께 알아 두세요.

수준	특성	필요한 대응
일반적 수준의 문제행동	타인에게 혼란을 주지 않거나 미미한 정도	예방적·보편적 지도, 일상적 수용
일시적 위기행동	순간적으로 본인·타인에게 위협이 되거나 기물을 파손할 가능성이 있는 행동	안전 확보를 위한 즉각적 중재
집중 관리가 필요한 행동	반복·간헐적으로 위기를 일으켜 지속적으로 위협을 가하는 행동	교내 인력 투입과 강도 높은 집중 관리

1.2 위기행동의 7단계 순환 주기

행동은 '통제' 상태에서 출발해 유발 자극을 거쳐 '위기'에 이른 뒤 다시 '회복'됩니다. 단계별 징후를 읽어야 골든타임을 놓치지 않습니다.

0 통제 ➔ 1 유발 ➔ 2 흥분/가속 ➔ 3 위기 ➔ 4 진정 ➔ 5 회복 ➔ 6 가라앉음

단계	학생 상태 · 징후 (예시)	교직원의 적절한 대응
0 통제 (관리 가능)	정서가 안정되어 규칙과 수업에 적응. 지시 이행, 긍정적 상호작용. *예: 교사·또래와 상호작용하며 지시를 잘 따름*	**긍정적 지원** — 기대행동 강화, 칭찬. 평소 AAC·감정 조절 시나리오 지도(2장)
1 유발	어려운 과제, 친구 반응, 환경 스트레스 등으로 불쾌감·짜증 시작. 화낼 기미, 당황, 언어적 거부. *예: 음료수를 거절당하자 큰 소리로 조르기 시작*	**유발요인 최소화** — 차분히 대처하고 주의 환기, 타임라인 설명. 어려운 과제는 대안 과제로 교체, '빈백 의자 이동 사진 카드'를 조용히 제시
2 흥분 /가속	감정 조절이 급격히 무너짐. 소리 지름, 욕설, 물건 던짐, 밀침, 호흡 가빠짐. *예: 벌떡 일어나 "지금 바로!"라고 소리침*	**두 가지 선택 제안**으로 경계 설정, 위험물 제거. 안전거리 확보, 짧고 단순한 지시, **2차 자극 금지**(1.3절)
3 위기	이성적 통제 상실. 극도의 자해·타해, 교사·또래 폭행, 기물 파손, 신체 접촉 격렬 거부. *예: 바닥에 드러누워 구르며 통제 불능*	**안전 우선·최소 제한** — 말을 줄이고 신속히 도움 요청, 또래 대피, 교내 응급체계 가동(4장)
4 진정	행동이 꺾이고 가라앉는 시기. *예: 교실 뒤 사물함 앞에 조용히 서 있음*	**구조화된 완화** — 사람·소음·빛 등 추가 자극 차단, 자기제어 시간 존중. 질책·훈계·추궁 금지
5 회복	평소 상태로 복귀. 의사소통 재개, 피로감, 이전 행동에 대한 당황·불안. *예: 자리로 돌아와 조용히 앉음*	**긍정적 지원** — 이전 사건 언급 금지, 정상 일과 재개, 대안행동 강화
6 가라앉음	평소보다 지쳐 있음. *예: 30분 동안 잠이 듦*	**휴식 제공** — 조용한 휴식 허용

※ 학생에 따라 특정 단계를 건너뛰거나, 개입 방식·환경 자극에 따라 이전 단계로 되돌아갈 수 있습니다.

현장 노하우 2단계에서 3단계(위기)로 넘어가는 순간은 눈 깜짝할 사이에 옵니다. 교사의 목소리가 커지거나 물리적으로 억압하면 그것이 2차 자극이 되어 위기 진입이 빨라집니다. 학생의 호흡이 빨라지고 목소리가 높아질수록 **교사가 먼저 낮고 나직한 톤**으로 지시를 단순화하세요.

1.3 흥분/가속 단계 접근 10대 행동 수칙

언어적 접근 (1~5)

1. **존중하는 태도로 간결하게** 말한다. 이름을 나긋하게 부르며 단호하고 명확하게 전달한다.
2. **현재의 문제에만 집중**한다. 지나간 일을 언급하지 않는다.
3. **힘겨루기를 피한다.** 논쟁·자존심 싸움으로 번지지 않게 대치를 완화한다.
4. 행동이 고조되면 **토론을 즉시 중지**하고 위기관리계획 절차를 이행한다.
5. 협조적인 모습이 보이면 **즉시 인정하고 칭찬**한다.

비언어적·신체적 접근 (6~10)

6. **천천히 움직인다.** 갑작스러운 동작은 위협 자극이 된다.
7. **공포·불안을 드러내지 않는다.** 침착함을 유지한다.
8. **신체 동작을 최소화**한다. 손가락질, 강한 주시를 삼간다.
9. **적절한 거리**를 유지한다. 팔 하나를 뻗는 정도의 안전거리.
10. **눈높이를 맞춘다.** 자세를 낮춰 위압감을 줄인다.

3단계 진입에 대비해 돌발 폭행·발길질을 피할 **신체적 안전거리**를 확보하고, "깊은 숨을 3번 내쉬어 보자", "두 팔로 몸을 감싸보자"처럼 **짧고 명확한 지시**를 사용합니다. 절대 소리를 지르거나 신체를 강제로 통제하려 하지 않습니다.

1.4 위기관리계획(CMP)과 긍정적 행동지원(PBS)의 관계

PBS 체계에서 위기관리계획은 **3차 예방(집중 지원)**에 해당합니다. PBS가 행동의 기능을 평가하고 예방하며 대체행동을 가르치는 것이 목적이라면, 위기관리계획은 행동 수정이 아니라 **학생과 주변인의 신체적·심리적 안전 확보**를 최우선 목적으로 합니다. 성공적인 위기 대처의 4대 기본 가정은 다음과 같습니다.

1. **조직·환경 구성의 선행** — 교내 대응 조직과 물리적 안전 환경을 미리 갖춘다.
2. **주양육자와의 협력** — 행동의 배경과 맥락을 이해하고 대처 방안을 마련하도록 지속 소통한다.
3. **보호자 사전 서면 동의** — 상황 분리·적극적 개입(위기관리계획 실행)에는 사전 동의가 필수다.
4. **이전 환경으로의 복귀** — 공간적 분리가 있었다면 진정 후 반드시 원래 학습 환경으로 돌아온다.

2. 평가와 예방 중재 (PBS)

위기행동 중재의 성패는 사후 대응이 아니라 **정밀한 기능 평가와 객관적 진단**, 그리고 환경 자극을 먼저 조절하고 대체 의사소통을 가르치는 **예방 중재**에 달려 있습니다. 징벌적 접근을 배제하고, 교사·보호자·행동중재 전문가·정서/정신건강 전문가가 함께 평가합니다.

2.1 진단·평가 도구

① 강화제 평가 설문지 RAISD (자극 선호도 파악)

중도중복장애 학생이 선호하는 강화 자극을 교사·보호자에게서 구조적으로 수집해 대체행동 교수와 강화에 활용합니다. 10개 영역은 다음과 같습니다.

영역	확인하는 선호 자극 예시
시각 · 청각	거울, 불빛, 반짝이는 물건, 돌아가는 사물, TV / 음악, 자동차·휘파람·사이렌·손뼉 소리, 노래
후각 · 미각	향수, 꽃·커피·소나무 향 / 아이스크림, 피자, 주스, 감자칩, 햄버거
신체 놀이 · 온도	간지럼, 레슬링, 뛰기, 춤, 그네 / 눈·아이스팩, 손난로·핫팩
기타 감각	세면대에서 물 뿌리기, 피부에 진동기 대기, 선풍기 바람

영역	확인하는 선호 자극 예시
타인의 관심	안아주기, 토닥이기, 손뼉, "정말 잘했어" 같은 승인
장난감·물건 / 기타	퍼즐, 장난감 자동차, 풍선, 만화책, 비누방울 / 혼자 또는 함께할 때 선호하는 활동

정밀 진단을 위해 **추적(Follow-up) 질문**을 함께 씁니다. 예) "가장 좋아하는 TV 프로그램은?", "거울을 볼 때 어떤 행동을 보이나요?", "혼자 있을 때 어떤 활동을 하나요?", "이 활동을 혼자 더 하나요, 다른 사람과 더 하나요?"

② 위기분류척도 CTRS (정신과적 위기 즉시 분류)

세 영역을 각각 1~5점으로 평가해 합산합니다. **Rating A 위험성**(자·타해 사고/행동, 폭력·충동성 조절), **Rating B 지지체계**(가족·친구·기관의 지지 존재와 제공 능력·의지), **Rating C 협조능력**(치료 개입에 대한 거부·수동 수용·적극 협조). 점수 판단이 갈리면 **더 위험한 고위기 단계의 점수**를 부여해 선제적으로 개입합니다.

총점	위기 수준	대응 지침
3~9점	극도의 위기상황	즉각적인 서비스와 입원 조치 필요
10점	고위험 상황	입원 가능성 검토·외래 치료 필요. **2시간 이내 현장 출동**으로 즉각 개입 (9~10점은 면밀한 임상 재평가)
11점	중간 정도의 위기	12시간 이내 접촉, 외래 치료 권유
12~13점	낮은 위험성	48시간 이내 접촉 (전화·내소·가정방문)
14~15점	위기상황 아님	2주 이내 개입, 정신건강 서비스 제공

③ 그 밖의 평가 도구

도구	대상 · 내용	판정 기준 · 활용
IES-R-K 외상 후 스트레스 선별검사	위기 사건 후 교사·학생의 PTSD 수준. 지난 1주간 침투 기억, 수면 장애, 예민·분노, 회피·무감각, 신체 반응, 재경험 등 22문항(0~4점)	**17점 이상** PTSD 가능성 → 징후 모니터링 **25점 이상** 가능성 매우 높음 → 정신건강의학과 치료 연계
Conners-Wells' 자기보고형 검사	청소년(중·고등학생)이 스스로 보고하는 ADHD 성향·충동성 선별	ADHD 의심: 중1·2 **41점**, 중3 **44점**, 고등 **42점** 이상 → 전문의 정밀 진단 권유
단축형 감각 프로파일 SSP	Dunn(1999). 만 3~10세. **부모 자기보고식**. 38문항 (190점 만점, 5점 리커트), 7개 영역(촉각·맛/냄새·움직임 민감성, 과소반응/감각추구, 청각 여과, 활력부족, 시각/청각 민감성)	정상(155~190점)·의심·문제 범주 선별
감각처리평가 SPM (학교용)	특수교사·치료사가 **학교 환경에서 아동을 직접 관찰·평가**. 7개 영역(사회참여, 시각, 청각, 촉각, 몸 인식, 균형과 움직임, 계획과 아이디어), N/O/F/A 척도	교실 내 감각처리 이상 반응을 다학제적으로 진단. **SSP와 평가 주체·척도가 다르므로 구별해 적용**
자해기초행동조사지 · ABC 기록	자해의 기능(감정 조절, 스트레스, 관심 유도 등)을 객관적으로 분석	처벌·감시가 아닌 수용적 공감 관계 형성이 목적

2.2 사회성·감정 표현·의사소통 중재

위기행동을 예방하는 가장 근본적인 방법은 부적절한 폭발 대신 **건강하게 상호작용하는 경험과 긍정적 의사소통 수단**을 늘리는 것입니다.

프로그램	목적	구체적 실행
또래 협동 놀이	또래에 대한 긍정적 관심, 신체적·사회적 협동을 통한 관계 형성	• 친구들과 탑 쌓기 (번갈아 올리며 공동 목표 달성) • 친구와 공 나르기 (2인 1조, 협동·속도 조절) • 친구에게 과자 먹여주기 / 친구가 주는 과자 먹기 • 친구 태우고 수레 끌기 / 친구가 끄는 수레 타기
감정 표현·의사소통	욕설·공격성 대신 감정과 상태를 명확히 표현하는 대안 기술 습득	• '좋아요' 카드(♡카드) 만들어 전달하기 • 좋고·싫음, 긍정·부정, 기쁨·슬픔, 재미·지루함 등 상반된 감정을 언어·표정·상징으로 표현 • 눈 마주 보며 인사하기 등 기본 사회적 기술 • 의사소통판으로 요구·감정 표현 (예: "나는 선생님이 좋아요")

2.3 보완대체의사소통(AAC) 도구 선택

구어 표현이 어려운 학생에게는 인지 수준, 운동 기능, 시각적 제약을 종합해 AAC를 선택합니다.

도구	주요 대상	핵심 기능 · 특징
나의 AAC My First	만 2~5세 아동	300여 단어 탑재, 단어 추가·편집 용이. 구글 플레이·앱스토어 (myaac.co.kr)
나의 AAC 기초	장애 정도가 심한 중증 장애인	선택하기·보고 말하기·듣고 말하기 의사소통판. 모든 모바일 기기
나의 AAC 아동	어린 연령의 아동	300여 상황 어휘, 상징 선택 시 확대·애니메이션 효과
나의 AAC 일반	읽기·쓰기가 가능한 학령기 이상	900여 상징, 상징 말하기와 문자 말하기 구분. 모바일·PC
스마트 AAC	운동 기능이 제한된 뇌병변장애, 시각 문제 동반	직접선택·스캐닝, 키가드, 스마트 키보드, 초기 상징 테스트, 상징 서버 공유 (smartaac.or.kr)
진소리	인지·운동 기능이 양호한 읽기·쓰기 가능 청소년·성인	글자 기반, 강의·발표용 장문 텍스트, 14개 상황별 문장, 사용 통계. 구글 플레이
모글 AAC	문장 표현이 가능한 아동	조사·연결어미 상징 제공(**모글 부호체계 사전 학습 필수**), 위젯, GPS 기반 장소·시간별 문장 추천. 유료 (mogulaac.com)
위드톡	취학 전·학령기 아동, 운동 기능 제한자 포함	스캐닝(셀/라인), 8개 범주 3,000여 상징(단어 1,200·문장 4,300), '명사+조사+동사' 문장 생성. 7인치 전용 단말기, 유료 (goodedu.com)
마이토키 시리즈	어린 연령~성인, 개인화된 음성 출력 요구가 큰 사용자	한국형 그림상징 10,000여 개, 다양한 연령·성별 음색, 존대/시제/문장 예측. 보드(인쇄 전용)·윈도우·스마트 (mytalkie.co.kr)

빠른 선택 가이드 — 중증 인지장애·초기 의사소통: 나의 AAC 기초, My First / 뇌병변·운동·시각 장애 동반: 스마트 AAC, 위드톡 / 문장 구성·문법 학습: 모글 AAC, 위드톡 / 읽기·쓰기 가능: 진소리, 나의 AAC 일반. 위드톡·마이토키는 정보통신보조기기 보급제품입니다.

2.4 관계 이야기(Social Story): '○○의 빈백 이야기'

분노·충동성이 높은 학생이 폭발하기 전에 **안전한 공간(빈백 의자)으로 이동**하고 의사소통 책을 쓰도록 돕는 시각적 시나리오입니다.

이야기의 핵심 구조

- 나는 ○○예요. 나는 빈백의자가 있어요.
- **화가 나면 빈백의자에 가서 앉아요.** 그러면 모두가 나를 자랑스러워해요.
- 빈백의자에서는 몸을 흔들어도, 잠을 자도 돼요. 앉으면 기분이 좋아요.
- **마음이 차분해지면** 의사소통 책에서 내가 원하는 그림을 손가락으로 짚을 거예요. 그러면 모두가 나를 자랑스러워할 거예요.
- 나는 오늘 하루를 멋지게 보낼 거예요.

제시 타이밍 (전이 지원)

- ① 등교 전 집에서, 등교 직후 학교에서
- ② 점심 먹기 전
- ③ 치료실 가기 전, 도착 직후
- ④ 귀가 직후
- **화낼 기미가 보이면** 교사·보조인력이 즉시 '빈백 의자로 가는 사진'을 보여 행동을 상기시킨다.

행동 폭발(Extinction Burst) 주의 중재 초기에 기존 방식으로 요구가 관철되지 않으면 문제행동이 일시적으로 **더 강하게 증가**할 수 있습니다. 중재 실패로 오인해 포기하지 말고, 일관되고 단호한 태도로 빈백 이동과 대체 의사소통 수단을 **조용히 계속 제시**하세요.

2.5 상황별 대체행동 지도

상황	지도 절차
A. 친구가 같이 놀자고 할 때 (거절·수용 표현)	1. 놀고 싶으면 "그래, 좋아", "같이 놀자"로 수락한다. 2. 놀기 싫을 때 도망치거나 욕하지 않고 **"싫어, 나는 다른 놀이 할래", "혼자 놀고 싶어"**라고 말한다. 3. 친구가 "알았어", "괜찮아, 다음에 같이 놀자"로 반응함을 이해시켜 예측 가능성을 높인다.
B. 수업이 어렵고 힘들 때 (도움 요청)	1. 과제가 어려워 화가 나는 감정을 스스로 인식하게 한다. 2. 폭발·거부 대신 손을 들고 **"선생님, 저 과제가 어려워요"**라고 말한다. 3. 특수학급 별도 과제를 보이며 **"이걸로 해도 돼요?"**라고 정중히 묻는다.
C. 화가 났을 때 (신체 조절·감정 표현)	1. 물건을 던지거나 욕·소리 지르면 또래 관계가 나빠진다는 결과를 이해시킨다. 2. **깊은 숨 3번 내쉬기**, 두 팔로 몸 감싸기, "쉬고 싶어요" 요청 중 하나를 실행한다. 3. "나는 지금 화가 났어요"라고 감정을 말로 전달한다. 4. 성공 시 **칭찬 스티커**로 즉시 강화한다.

3. 교내 위기관리 체계 구축

위기 때 개인 교사의 돌발 판단에 의존하면 2차 피해와 인권 침해 논란을 부를 수 있습니다. 학교 차원의 체계를 **미리** 갖추고 모든 구성원이 합의된 절차로 움직여야 합니다.

3.1 행동관리위원회와 역할 분담

학교는 위기 예방, 합리적 의사결정, 사후 관리를 맡는 **행동관리위원회(행동심의중재위원회)**를 설치·운영하고, 필요하면 외부 전문가와 협력합니다. 현장 투입 인력은 **2인 1조 현장 대응 모듈**이 기본입니다.

담당	역할
교감	교내 대응 총괄, 비상 연락망 수신, 현장 투입 총괄, 보호자 연락 조율. 미진정 시 조기 귀가·의료 개입 결정
담임교사	위기 학생 진정 유도, 언어적 행동 기대 제시, 일화기록·ABC 관찰 기록 작성
특수교사	IEP 연계 위기관리계획 수립, 행동 중재 지도, 사후 중재안 수정
보건교사	부상자 응급처치, 119 구급대 연계, 보건 인프라 지원
전문상담교사	학생 심리 안정, 사후 상담, 필요 시 외부 상담기관 연계
행정직원 (1인 이상 지정)	담임교사와 2인 1조로 학생의 행동지원실 이동 지원
특수교육실무사	피해·또래 학생을 지정 특별실(과학실, 미술실 등)로 대피시키고 교실 분위기 안정화. 대피 학생에게 **정서 안정 활동**(자율 독서, 시각적 안정 카드, 보드게임 등) 즉시 제공

3.2 행동지원실(심리안정실) 운영

강한 자극을 차단하고 심리적 안정과 회복을 도와 다시 교육 환경으로 복귀시키는 특별실입니다. 심각한 타해·자해로 수업이 불가능하고 안전 확보가 시급할 때 이용합니다. 이동 후에는 단호하고 명확한 기대(예: **"2분 동안 조용히 앉아 있기"**)를 제시하고, 안정되면 즉시 원래 교실로 복귀시킵니다.

교실·물리적 환경 구성

- 가위·칼·스테이플러 등 날카로운 문구류는 평소 **잠금장치가 있는 자료함**에 보관한다.
- 수업 중 날카로운 도구를 쓸 때는 교사·실무사가 밀착 지도한다.
- 주방용품·유리 제품 등 잠재적 위험 물품이 교실에 들어오지 않게 차단한다.

3.3 제한적 신체 개입의 4대 원칙과 인권 보호

신체적 구속·물리적 제압은 원칙적으로 허용되지 않습니다. 본인이나 주변인의 생명·신체에 심각한 상해가 우려되는 **극도로 긴급한 예외 상황**에서만, 상황을 중단할 목적으로 최소한으로 시행하며, 반드시 **정식 훈련을 받은 직원**이 집행합니다(영국 보건부·BILD 가이드라인 근거).

원칙	내용
1. 최소화	극도로 심각한 경우에만 제한적으로 적용하고 물리적 제압을 최소화한다.
2. 대안적 방법 선행	대신할 수 있는 중재 기법이 있다면 먼저 적용한다.
3. 안전한 환경 제공	학교는 안전한 물리적·정서적 공간이어야 하며, 개입은 그 안전을 지키는 목적에 한한다.
4. 합리적·적절한 개입	안전 확보라는 목적 달성에 필요한 과도하지 않은 수준에서만 개입한다.

3.4 보호자 소통과 서면 동의

- **IEP 수립 시 '긍정적 행동지원 및 위기관리 계획'을 명시**하고, 작성 단계에서 보호자 **서면 동의**를 받는다.
- 동의서에는 심각한 공격·자해 때 적용할 구체적 절차(행동지원실 이동, 타임아웃, 제한적 신체 구속의 조건 등)를 상세히 설명하고 서명을 받는다.
- 위기행동이 발생하면 **당일 즉시** 보호자에게 경위를 알린다.
- 위기관리계획에 대한 **이의제기 절차**와 그 범위·처리 권한을 규정에 명시한다.

3.5 사전 점검 체크리스트

영역	점검 항목	확인
평가와 참여자 동의	행동과 그 위험을 구체적·객관적으로 관찰·기술했는가?	☐
	위기행동 전에 나타나는 전조 징후를 구체적으로 확인했는가?	☐
	영향을 받는 사람과 위험의 유형·강도를 점검했는가?	☐
	교직원·학생·보호자가 판단 및 대처계획에 합의했는가?	☐
개입과 실행	개입·모니터링을 위한 교내 위원회가 마련되어 있는가?	☐
	초기 면접이나 IEP 작성 시 위기행동 개입 항목이 포함되어 있는가?	☐
	모든 구성원이 지원계획과 긍정적 예방 접근법을 숙지했는가?	☐
	위기 개입 시 긴급지원 관련 위험사항과 실행 방법을 숙지했는가?	☐
학생·보호자 참여	계획 수립 과정에 학생과 보호자의 참여 기회를 제공했는가?	☐
	위기관리계획 문서에 학생·가족의 서면 동의를 받았는가?	☐
	이의제기 절차를 마련하고 범위와 권한을 명시했는가?	☐

4. 위기 발생 시 단계별 대응

4.1 현장 5단계 표준 대응 절차 (SOP)

1 분리·대피 ➔ 2 비상연락 ➔ 3 이동·모니터링 ➔ 4 복귀·재개 ➔ 5 문서화·보고

1. **분리·대피** — 공격이나 중증 자해가 발생하면 학생에게 언어적으로 명확하고 단호하게 멈추라고 요구한다. 실무사·동료 교사의 도움으로 피해 학생과 또래를 인근 안전 장소로 즉시 대피시키고 정서 안정 활동을 제공한다. 부상자는 보건실로 이동하거나 필요 시 즉시 **119**에 신고한다.
2. **비상연락** — 대피를 마친 인력이 보건실·교감·행정실 등 지정 인력에게 신속히 상황을 전달한다. 연락받은 교감과 행정직원은 즉시 현장으로 이동해 담임교사와 **2인 1조**로 투입된다.
3. **이동·모니터링** — 담임·교감·행정직원이 협력해 학생을 행동지원실로 안전하게 이동시킨다. 공격 시도를 차단하고 진정 요건("2분 동안 조용히 앉아 있기")을 제시하며 상태를 지켜본다. 대피했던 또래는 교실로 복귀시킨다.
4. **복귀·재개** — 안정되면 행동을 스스로 돌아보게 하고 행동 지침을 안내한 뒤 교실로 동행한다. 복귀 후 행정직원·실무사·담임이 옆에서 **10분간 밀착 관찰**하며 정상 수행을 확인하고 일과를 재개한다.
5. **문서화·보고** — 일화기록과 ABC 관찰 기록을 작성하고, 위기행동 대처 사후보고서를 학교장·관련 부장에게 보고한다. 알림장이나 유선으로 보호자에게 경위와 조치를 알린다.

미진정 시: 조기 귀가·응급 의료 개입 일정 시간(예: 15~20분 이상)이 지나도 극심한 폭발 상태가 진정되지 않고 본인이나 교직원의 안전을 계속 위협하면, 교감이 사전 협의된 위기관리계획과 보호자 사전 동의 규정에 따라 **조기 귀가 및 응급 의료 개입**을 결정합니다. 즉시 보호자를 호출해 인계하고, 신체 손상이나 극심한 흥분이 지속되면 **119**와 연계 의료기관(소아청소년 정신건강의학과·발달장애인 거점병원)으로 긴급 호송합니다.

4.2 정신응급개입(☎ 1577-0199)과 위험도별 절차

CTRS 평가(2.1절)에서 **고위험 이상**이면 정신응급개입전화로 연락하고, **경찰·소방 3자 통화**로 정신건강전문요원·경찰·소방 구급대원의 동시 출동과 119 병원 이송을 요청합니다. 24시간 위기 평가가 이루어집니다.

경찰·소방 3자 통화 ➔ 1차 전화상담 평가 ➔ 고위험 시 현장출동 ➔ 2차 현장 재평가

위험도	1차 전화상담 평가 후 대응	현장 출동 후 2차 재평가 대응
저위험	정서적 지지 상담, 금주·약물 교육, 정신건강 정보 제공	정서적 지지 상담, 금주·약물 교육, 정보 제공
중위험	지역 정신건강서비스 안내·연계, 병식 향상 교육, 정신건강의학과 정보 제공	정서적 지지 상담, 약물 교육, 서비스 안내·연계, 병식 향상 교육, 정신건강의학과 정보 제공
고위험	**경찰·소방·정신건강복지센터 현장출동 체계 즉각 가동**	정신건강의학과 치료 연계, 자살 위험성 평가·위험요인 제거, 본인·보호자·현장인력 교육, 본인·보호자 모니터링, 지역 서비스 연계

현장 노하우 전화할 때 "학생이 폭력적이에요"라고만 하지 말고 **"CTRS 평가 결과 10점 이상의 고위험 상황이며 현장 자·타해 위험이 있으니, 3자 통화로 경찰과 소방의 즉시 동시 출동을 요청합니다"**라고 명확히 말하세요. 현장 출동 속도가 달라집니다.

보호자가 치료에 동의하지 않을 때

전문 치료가 꼭 필요한데 보호자가 외부 기관 연계와 치료 동의를 거부하면 **'의료적 방임'**에 해당할 수 있습니다. 이때는 학교 규정 또는 학교장의 판단에 따라 보호자 동의와 무관하게 전문기관 연계를 추진할 수 있습니다. 조현병 등 정신과적 증상의 치료는 **정신치료(왜곡된 인지 교정)·약물치료(신경계 반응성 보호)·입원치료(정확한 진단, 일관된 투약, 자·타해 위험 방지; 무의미한 장기 입원은 지양하고 조속한 지역사회 복귀를 목표)**로 이루어집니다.

4.3 응급사고 보고 체계와 이송 관리

최초 발견자 ➔ 인근 교사 ➔ 보건교사·담임교사 ➔ 교감 ➔ 교장

담당	행동 수칙
최초 발견자	환자 곁을 떠나지 않고 응급 여부를 파악하며, 가까운 교사에게 보고를 요청한다.
인근 교사	보건교사·담임교사에게 즉시 연락한다.
보건교사·담임교사	상태를 평가하고 필요 시 심폐소생술 등 응급처치, **즉시 119 신고**. 이송은 119 구급대가 원칙이며 **담임교사는 부득이한 경우를 제외하고 동행**(출장 처리)한다. 보건교사가 동행하면 사전 지정된 **보건실 업무대행자**(보건실 구조·물품 위치와 사용법·보건일지 등을 숙지)가 보건실을 관리한다.
교감·교장	최종 보고를 받고 이송 교사의 **수업 대체인력**을 투입하며 행정실·보호자 연락 체계를 총괄한다.

동행 교사의 행정 서류: ① 이송교사 보고서 ➔ ② 출장신고서 ➔ ③ 필요경비 신청서. 이어 행정실이 **안전공제회 보상 신청**을 진행하고, 담임교사가 보호자 연락 체계를 구축해 병원 방문 보고를 수행합니다.

4.4 현장 공통 수칙

- **자가 판단 금지** — "이 정도는 괜찮겠지"라고 넘기지 말고 보건교사·119 등 전문가와 즉시 상의한다.
- **현장 보존과 증거 확보** — 소송·경찰 조사에 대비해 현장을 훼손하지 않고 사진을 찍으며, 목격 학생·교사의 진술과 기록을 확보한다.

- **대외 창구 단일화** — 보호자와 감정적 논쟁을 피하고, 대외 대응 전담자를 **교감(또는 교무부장, 안전부장)**으로 일원화한다. 출석·성적은 피해 학생 입장에서 신속히 처리한다.
- **기록은 객관적으로** — 사후 일화기록은 **ABC 사건기록법**(배경 사건 ➔ 선행 사건 ➔ 위기행동 ➔ 대응·결과)으로 쓰되, 객관적 사실과 작성자의 느낌·추측·주관적 해석을 엄격히 분리한다. 사후보고서는 보호자 상담과 행동 기능 분석의 기초 자료로 보관한다.
- **부적절한 친근감 표현 시** — ① 피해 대상(여성 직원, 방문객 등)에게 학생의 장애 특성을 객관적으로 설명하고 **이해와 양해**를 구한다. ② 친근감을 보인 대상과 원인을 변별해 물리적 거리를 확보하고 인적·공간적으로 분리한다.

4.5 외부 전문기관 연계

기관	연계 내용
소아청소년 정신건강의학과	공존질환(ADHD 등) 진단, 약물 치료 평가·자문
발달장애인 거점병원 · 발달장애행동증진센터	정밀 행동 진단, 전문 행동중재 연계
Wee 센터 · 청소년상담복지센터	정서 지원, 학생·가족 심리 상담
교육청 법률 자문단 · 외부 법률기관	학교폭력, 법적 분쟁, 학교 안전망 구제 자문

5. 유형별·상황별 사례와 맞춤 전략

위기행동은 언어적 결함, 감각처리 이상, 정서적 불안 등 다양한 원인에서 나옵니다. 행동의 의사소통적 기능을 **기능평가(FBA)**로 파악해 유형에 맞는 개별화 중재를 제공합니다.

5.1 타인 공격·심한 수업 방해 사례 1·2·6

사례	학생	행동 특성
1	중2·남 지적장애	구어 의사소통 불가(과제 회피·관심 끌기). 교사·약한 또래를 꼬집고 때림. 머리로 교사 얼굴 공격, 책상을 밀어 던져 뇌진탕 유발. ADHD 공존 의심
2	초4·남 자폐성장애	지시 불응 시 손등 피부 뜯기, 가위·날카로운 펜으로 타인 위협, 유리창·거울 파손, 큰 의자 던지기
6	초4·남 자폐성장애	바닥에 누워 고성. 일으키려는 교직원의 발을 걸어 넘어뜨려 가격(코뼈·갈비뼈 타박상). 높은 철봉·나무에 올라가는 위험 행동

- **AAC 도입** — 공격성을 대신할 그림상징·의사소통판 체계. 'WebAAC'의 10,000여 개 한국형 상징으로 "주세요", "싫어요", "도와주세요"를 시각화해 지도한다.
- **시각적 지원·환경 수정** — 활동 전이 시 행동 규칙을 담은 시각 스케줄과 그림 카드를 제공한다. 날카로운 문구류는 사용 후 즉시 잠금 보관하고 민감한 신체 접촉을 최소화한다.
- **다학제 의뢰** — 과잉행동·충동성이 극심하면(사례 1) 거점병원 등 정신건강의학과에 검사를 의뢰하고, 교사의 일화기록과 ADHD 평가척도 자료를 제공한다.

5.2 자해행동 사례 3·4

사례	학생	행동 특성
3	고2·여 지적장애 (은폐형)	타인 공격은 없으나 칼로 몸통 전체를 긋거나 피부를 벗겨냄. 교우관계 고립, 중학교 때 사이버 폭력·따돌림 피해, 부모의 방임적 태도
4	중3·여 지적장애 (중증 방출형)	머리를 바닥·벽에 세게 부딪쳐 뇌진탕으로 입원한 이력. 제지하면 팔을 휘두르며 공격, 최근 손·팔을 물어뜯는 중증 자해

- **신체 보호·응급 대응** — 자해가 심하면 보호자 사전 동의 하에 머리 보호용 **헬멧** 등 보호장구를 착용한다. 영구 손상·심각한 부상(출혈, 뇌진탕 위험)은 즉시 보건실 응급처치와 119 신고, 보호자·학교장 보고.
- **원인 탐색** — 은폐형 자해(사례 3)는 처벌·감시가 아니라 **자해기초행동조사지**로 기능을 분석하고 수용적 공감 관계를 만든다.
- **감각 관련 자해** — 감각조절·자극 기능이 의심되면 SSP(부모 보고)와 SPM(교실 관찰)을 구별해 적용한다(2.1절).

5.3 성적 행동 · 신체 이탈/고립 사례 5·7

사례	학생	행동 특성
5	초5·남 지적장애 (성적 행동)	교사·또래 여자아이의 옷을 만지고 치마를 들추고 껴안음, 교실 내 자위행위 시도. 가정 내 비난으로 행동이 강화됨
7	초6·남 자폐성장애 (이탈·고립)	155cm·150kg의 고도비만. 사춘기 변화로 장소 이동을 강하게 거부하고 주저앉음. 강제 이동 시 주먹 폭행과 벽에 머리 박기(자해·타해 동시)

사례 5: 신체 몸짓 모델링과 성범죄 사안 대응

- **"좋아요"** 엄지 치켜세우기·고개 끄덕이기 / **"싫어요"** 고개 또는 편 손 좌우로 흔들기 / **"안돼!"** 두 팔을 가슴 앞에서 교차해 'X' 만들기 + "안돼요! 그만!". '내가 좋아하는 것 책', '내가 싫어하는 것 책', '좋아요/나빠요 의사소통 책'으로 공적·사적 경계를 교육한다.
- **사안 인지 즉시 경찰·긴급 신고망에 신고**한다.

학교폭력 신고·상담	여성긴급전화	해바라기센터	여성폭력 사이버상담
☎ 117 (#0117)	☎ 1366	☎ 1899-3075	www.women1366.kr

- **증거 보전** — 피해 아동은 몸을 씻기지 않은 상태로 병원 진단을 받게 하고, 모든 증거물은 비닐이 아닌 **종이봉투**에 담아 수사기관에 의뢰한다.
- **조사 수칙** — 가해 학생의 교내 조사는 학습권 보장을 위해 **휴식 시간 또는 일과 후**에 실시하고, 수사기관 조사에는 보호자·교직원이 동행한다.

사례 7: 이동 거부 중재

- **몸짓상징 '손담' 활용 화장실 지도** — 온맘(nise.go.kr/onmam)의 수어 기반 몸짓상징을 도입한다. 장소는 교실·화장실, 시간은 등하교 직후와 매 3교시 쉬는 시간. 소변 상황 카드를 보이며 "화장실 가고 싶어요?"라고 묻고 '화장실(소변보다)' 동작을 반복 지도한다.
- **가정 연계** — 월~일 아침·점심·저녁·간식의 메뉴와 열량(kcal)을 기록하는 **주간 식단표**로 영양과 식탐을 통합 관리한다.
- **Now-Then 시각판**(선행 활동 ➔ 강화 활동)을 쓰고, 체격에 맞지 않는 세면대·책상·의자를 대형 규격으로 교체한다.

5.4 지적·청각 중복장애와 복합 위기 사례 8

사례 8 (초2·남, 지적·청각 중복장애): 한쪽 청력 손실과 언어 지연. 수업 중 고성, 또래가 다가오면 물건을 던지거나 물어뜯음. 한부모 가정에서 주양육자가 가정폭력 피해와 극심한 우울증을 겪고 있음.

- **RAISD로 강화제 선별** — 청각 보상은 효과가 떨어지므로 **시각적 강화물**(반짝이는 빛, 시각적 장난감)과 **촉각적 강화물**(진동 장난감, 부드러운 감각 도구)을 선정해 바람직한 행동 직후 즉시 제공한다.
- **1:1 구조화 훈련·가정 지원** — 그림교환 의사소통체계(PECS)를 1:1로 지도하고, 관할 복지관·상담기관과 연계해 주양육자의 심리 치료와 양육 태도 개선 연수를 제공한다.

6. 사후 행정·법률·회복 지원

6.1 사고 통지와 보상·변상 절차

교육활동 중 사고는 **경미해 보여도 지체 없이** 공제급여관리시스템(schoolsafe.or.kr)에 사고발생 통지를 합니다. 나중에 관절·인대 손상이 드러났을 때 통지가 늦으면 사고와의 인과관계 입증이 어렵고 학부모 민원의 원인이 됩니다. 보상 가능 여부를 학교가 예단해 청구를 포기하지 말고 안전공제회에 직접 문의하세요.

대상	적용 제도 · 기관	절차 · 구비서류 · 유의점
사고 학생	학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 / 학교안전공제회	치료 후 학부모가 시스템으로 청구. **공제급여청구서, 진단서(50만 원 이상 청구 시; 미만은 생략 가능), 진료비·약제비 영수증(카드매출전표 불가), 진료비 상세내역서(비급여 시), 주민등록등본, 청구인 통장 사본** 공제 제외: 개인 부주의 사고, 가해자가 있는 고의·과실 사고, 등하교 시 자동차 사고
특수교육지원인력(사회복무요원 제외)	산업재해보상보험법 / 근로복지공단	산재 지정 의료기관 확인 ➔ **요양급여신청서** 제출 ➔ 7일 이내 승인 여부 통지. 자비 치료 시 요양비 청구, 학교가 선부담했다면 **보험급여대체 청구·증명서** 제출
사회복무요원	교내 공상 처리 / 공상심의위원회·교육지원청	교내 **공상심의위원회** 개최 ➔ 교육지원청에 공문(회의록, 부상확인서, 치료신청서) ➔ 일괄 가입 보험사 연계. 1회 5만 원 이하의 응급 처치·검사비는 학교운영비(공상 치료비 예산)로 자체 처리 가능
기물 파손	학교 자체 처리 규정 / 학교·보호자	구입금액과 사용연한을 고려해 학생(학부모) 변상이 원칙. **특수학교** 소액은 학교 예산 부담, 대형 파손은 학교·학부모 비율 분담 **일반학교** 소액은 학부모 변상, TV 등 대형 수리비는 학교 예산 처리 경향

6.2 교육활동 침해 행위의 법적 개념

유형	성립 기준	법률 유의점 · 판례
폭행	신체에 직접·간접적으로 힘을 가하는 행위. 때리기·밀치기·멱살 잡기뿐 아니라 **물건을 던지거나 팔다리를 휘둘러 때리려는 거동**(간접 유형력)도 포함	피해 교원이 처벌을 원하지 않는다고 명시하면 처벌할 수 없는 **반의사불벌죄**
모욕	사회적 평가를 떨어뜨릴 만한 경멸적 감정 표현. **공연성**(다수인이 인식 가능한 상태)이 전제	**친고죄**(피해자의 직접 고소 필요). 교사와 1:1 전화 중 욕설은 공연성이 없어 모욕죄 불성립(다만 정보통신망법 위반 가능). 교무실에서 "나이가 몇 살이냐" 같은 무례·불쾌한 표현은 경멸적 표현이 아니면 불성립(대판 2015도2229)
손괴	타인의 재물·문서·전자기록을 망가뜨리거나 숨겨 본래 용도로 쓰지 못하게 하는 행위. 책상·창문·TV 파괴, 출석부·교무수첩 찢기, 컴퓨터 파일 숨기기 포함	교사 앞에서 욕하고 창문을 깨도 교사 개인에 대한 구체적 해악 고지가 없으면 협박이 아닌 **손괴**

유형	성립 기준	법률 유의점 · 판례
녹음	대화 당사자 일방이 상대 동의 없이 녹음하는 것은 통신비밀보호법 위반이 아님	폭언 녹음은 증거로 보호됨(대판 2013도16404, 2006도4981). **역(逆)녹음 주의** — 보호자·민원인이 교사와의 대화를 몰래 녹음해도 위법하지 않으므로 모든 상담에서 언행에 유의

현장 노하우 학부모가 교실로 찾아와 감정적으로 항의하면 초보 교사 혼자 맞서지 마세요. **"학교 규정상 사고 대응 창구는 교감 선생님으로 일원화되어 있습니다"**라고 안내하고 교감실로 모시는 것이 교사 자신을 법적으로 보호하는 길입니다.

6.3 교권보호위원회 (전라북도 기준)

- **구성·임기** — 위원장 1명 포함 7명 이상 10명 이하(교원, 학부모, 변호사, 경찰 등), 성별을 고려하며 임기는 3년 범위 내 1회 연임 가능.
- **분쟁 재조정 신청** — 학교교권보호위원회의 조정 불성립 통지를 받은 날부터 **1개월 이내**(미설치 유치원은 사안 발생일부터 3개월 이내) 학교장을 거쳐 제출.
- **조정 개시 거부·중지 사유** — 당사자 일방의 거부, 상대방 고소·고발 또는 소송 제기, 신청 내용이 거짓이거나 정당한 이유가 없다고 인정되는 경우.

6.4 교사 자신의 회복

위기를 중재하는 과정에서 교사가 입은 심리적 외상도 전문적으로 치료받아야 합니다. 불안, 수면 장애, 사건 재경험이 있으면 주저 없이 **IES-R-K**(2.1절, 17점 이상 PTSD 가능성 / 25점 이상 전문 치료 필요)로 자가 진단하고 도움을 신청하세요.

- **교원치유지원센터** — 교육활동 침해와 직무 스트레스를 겪은 교원에게 심리상담·치료비 지원과 법률 자문을 제공합니다. 지정 상담전문기관 **50개소**, 진료 지원 협력병원(정신건강의학과) **37개소**와 연계됩니다.
- **교원치유 휴(休) 프로그램** — '자연명상스테이'(숙박형) 등. 신청 사유를 적은 참가 신청서를 제출합니다.

6.5 장애아 가족 양육 지원사업 (☎ 보건복지콜센터 129)

구분	돌봄 서비스	휴식 지원 프로그램
지원 내용	양육자 질병 등이 생기면 돌보미 파견(가정 등). 1인 아동 연 480시간 범위, 월 80시간 이내가 원칙	문화·교육 프로그램, 휴식 박람회, 가족캠프, 돌보미를 통한 가족 상담·생활지도·자조모임, 가족 상담(치료)·부모 교육
지원 대상	만 18세 미만 1~3급 등록 장애아와 생계·주거를 같이하는 전국가구 평균소득 100% 이하 가정	소득 기준 없이 만 18세 미만 모든 장애아 가족 (돌봄 미이용 가구도 참여 가능, 이용 가구 우선)
이용 방법	읍·면·동 주민센터 방문 신청 후 결정	보건복지콜센터(129) 또는 사업 운영기관

7. 핵심 5대 수칙과 실행 제언

초보 교사를 위한 위기행동 대응 5대 수칙

1. **평소에 대체 의사소통(AAC)과 감정 조절 시나리오를 지도한다.** 화가 났을 때 폭력 대신 빈백 의자 이동이나 의사소통판 활용을 스스로 선택하게 돕는다.
2. **유발 자극을 즉시 차단하고 안정적 환경과 시각 지원을 제공한다.** 어려운 과제나 환경 자극을 조기에 제거해 흥분 가속을 막는다.
3. **흥분 시 안전거리를 확보하고 2차 자극을 최소화한다.** 소리를 지르거나 물리적으로 억압하지 않는다.
4. **위기 발생 즉시 교내 응급관리체계와 외부 기관(1577-0199 3자 통화, 119)을 가동한다.** CTRS에 근거해 경찰·소방·정신건강복지센터의 동시 출동을 요청한다.
5. **사고 후 현장을 보존하고 공제·산재 절차를 이행하며, 교사 자신의 심리적 외상을 치료한다.** 기록·보고를 정확히 하고 IES-R-K와 교원치유지원센터를 활용한다.

학교 현장 정착을 위한 4대 실행 제언

제언	내용
1. 정례적 교직원 연수	전 교직원과 실무사 대상으로 FBA, PBS, 위기 순환 주기(7단계)에 대한 실전 연수를 정기적으로 의무 실시한다.
2. 교육청–지역사회 협력망	발달장애인 거점병원, 발달장애행동증진센터, 소아청소년 정신건강의학과, 법률 자문기관과 MOU를 맺고 전문 지원단 파견 체계를 정례화한다.
3. 가정–학교 협력	주양육자 정서 지원, 양육 스트레스 상담, 장애 수용 부모교육을 확대하고 학교와 가정이 일관된 중재 전략을 유지한다.
4. 서식의 표준화·전산화	ABC 관찰기록지, 심리안정실(행동지원실) 이용기록서, 위기행동 대처 사후보고서, 자해기초행동조사지 등 핵심 양식을 표준화해 보급하고 모니터링한다.

기억하세요 학생의 인권·학습권과 교직원·또래의 안전권은 함께 지켜져야 합니다. 부적절한 남용적 격리나 과도한 신체 제압은 인권 침해가 될 수 있습니다. 보호자 서면 동의를 반영한 PBS·위기관리계획은 학생에게는 인권 친화적 보호막, 교직원에게는 법적·윤리적 보호 근거가 됩니다.